

2.5. Màng bám đặc hiệu – màng bám không đặc hiệu

Màng bám không đặc hiệu: có nhiều loại vi khuẩn thường gây bệnh viêm nướu. Thuyết màng bám không đặc hiệu căn cứ vào số lượng vi khuẩn, vi khuẩn nhiều gây bệnh nha chu.

Màng bám đặc hiệu: màng bám có vi khuẩn ngoại lai, vi khuẩn đặc hiệu xâm nhập.

Sự trưởng thành của màng bám: khi có sự gia tăng nhiều loại vi khuẩn. Có sự chuyển hóa từ vi khuẩn hiếu khí sang kỵ khí.

2.6. Phát hiện màng bám

Vật lý, cơ học: sử dụng dụng cụ cạo vôi, cây thám trầm.

Hóa học: dùng phẩm nhuộm màu màng bám disclosing tablet.

2.7. Kết luận

Màng bám vi khuẩn là yếu tố gây bệnh số 1 trong bệnh nha chu.

Màng bám dễ loại trừ.

Khuynh hướng điều trị: mang vi khuẩn bảo vệ tới vùng sang thương, thay đổi về mặt cơ địa tạo tích ứng tốt.

3. VÔI RĂNG

3.1. Định nghĩa

Vôi răng hay cao răng chính là mảng bám răng bị khoáng hóa, chúng được hình thành bởi mảng bám được ngâm trong dung dịch quá bão hòa các ion Ca^{2+} và PO_4^{4-} của

nước bọt. Vôi răng hầu như luôn luôn được bao phủ bởi một lớp màng bám không canxi hóa.

Vết dính: màng bám, màng bám và vôi dính màu vàng, nâu hay đen... tùy thuộc vào chế độ ăn uống, hút thuốc hay sử dụng hóa chất.

3.2. Quá trình hình thành vôi răng

Màng bám mới thành lập: gồm một khung hữu cơ và một số ion vô cơ. Và trong trạng thái mềm nhão.

Do hoạt động của vi khuẩn, nồng độ pH của màng bám giảm, có khuynh hướng kéo các ion vô cơ vào trong khung hữu cơ.

Khi các chất vô cơ đã tích tụ đủ, màng bám trở nên cứng rắn tạo thành vôi răng và vôi răng cũng là yếu tố trung hòa nồng độ pH của màng bám.

* Tuy nhiên, khi cao răng (từng lớp mỏng) đã được hình thành lại là một điều kiện lý tưởng để màng bám răng tích tụ và bám vào dẫn đến việc giảm pH và quá trình hình thành vôi răng lại tiếp tục.

3.3. Vôi răng trên nướu và dưới nướu (Subgingival calculus and supragingival calculus)

3.3.1. Vôi răng trên nướu *đề đang loại bỏ vì lực bám thấp*

Được hình thành từ màng bám trên nướu do sự tích tụ các ion vô cơ có trong nước bọt và thực phẩm.

Có màu vàng đục hay hơi xám, lực bám dính giữa vôi răng và răng khá thấp nên dễ dàng bị loại bỏ.

3.3.2. Vôi răng dưới nướu

Hình thành từ màng bám dưới nướu do sự tích tụ các ion vô cơ từ huyết thanh, dịch nướu và nước bọt.

Có màu đen, nâu hay xám do các hồng cầu bị vỡ tẩm nhuộm và vôi răng (vôi răng huyết thanh).

Do chịu lực ép của nướu viên vôi răng dưới nướu chỉ là một lớp mỏng.

Lực bám dính giữa vôi răng và bề mặt chân răng cao nên việc loại bỏ vôi răng dưới nướu khó khăn (một phần do vôi răng được lưu giữ bởi đường nối men-xê măng).

Vôi răng dưới nướu và màng bám dưới nướu là nguyên nhân chủ yếu phá hủy lớp biểu mô khe nướu và biểu mô bám dính EA (Epithelial Attach) gây ra bệnh nha chu.

nguyên nhân gây ra bệnh nha chu chủ yếu là vôi răng dưới nướu



Hình 2.1. Vôi răng trên nướu và dưới nướu.
(Nguồn: Carranza's Clinical Periodontology, 2015)

3.4. Sự khoáng hóa khi hình thành vôi răng

Màng bám được ngâm trong dịch nướu, nước bọt và huyết tương nên khi có sự thay đổi pH và hiệu điện thế gây ra sự chuyển dịch về điện dẫn đến sự chuyển dịch các ion.

Do màng bám có khung hữu cơ nên nó mang điện tích (-). Khởi đầu màng bám thu hút các ion (+) đặc biệt Ca^{2+} luôn có trong dịch tiết, khi các ion (+) đã được tích tụ thì màng bám lại bị thay đổi (đóng vai trò cực (+) lôi kéo các ion (-) như PO_4^{3-} (-) thâm nhập tạo thành phosphate calcium. Như vậy, sự khoáng hóa khi hình thành vôi răng chính là sự canxi hóa màng bám răng.

3.5. Các yếu tố thuận lợi để vôi răng thành lập

- Do vệ sinh răng miệng kém.
- Do mất răng mà không được phục hồi, nhai một bên, sâu răng.
- Do các phục hình sai, trám dư.
- Do các răng mọc lệch.
- Do các bệnh toàn thân.

3.6. Kết luận

Cùng với màng bám, vôi răng là yếu tố gây bệnh nha chu.

Loại trừ vôi răng, màng bám, hướng dẫn vệ sinh răng miệng tốt góp phần quyết định trong việc điều trị và dự phòng bệnh nha chu.

Bài 5.

YẾU TỐ NGUY CƠ BỆNH NHA CHU

TÌNH HÌNH BỆNH NHA CHU

Nha chu và sâu răng là hai bệnh phổ biến trong nha khoa không chỉ ở Việt Nam mà còn cả nhiều nước khác mặc dù ngày nay đã có nhiều phương pháp điều trị và đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.

Đầu thập niên 70, đã có mô hình hoàn chỉnh về viêm nha chu. Nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh nha chu ở những cá nhân có thể khác nhau về hình thức và mức độ nặng nhẹ do có sự khác nhau về loại vi khuẩn nguyên nhân hoặc do có mức độ đáp ứng khác nhau của chủ thể.

Goodson và cộng tác viên còn phát hiện trên mẫu nghiên cứu lớn rằng bệnh nha chu tiến triển theo chu kỳ gồm có những giai đoạn cấp xen kẽ nhưng giai đoạn yên nghỉ hoặc phục hồi. Tuy nhiên, không liên tục.

Thập niên vừa qua (những năm 90), những nhà dịch tễ học đưa ra khái niệm “những yếu tố nguy cơ”, tức là những yếu tố góp phần làm phát sinh và làm tiến triển NC.

1. NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ

Có thể chia làm 2 nhóm:

- Nhóm những yếu tố “bẩm sinh” hay còn được gọi là yếu tố “nền”.
- Những yếu tố mắc phải hoặc thuộc về môi trường.

Những yếu tố vừa nêu (bẩm sinh hay nền và mắc phải di truyền) xác định sự phát sinh, sự tiến triển của bệnh nha chu và xác định đáp ứng đối với điều trị nha chu.

Đóng góp của những nhà dịch tễ học là phát hiện vai trò của “những bệnh nha chu trung bình không được điều trị” (untreated moderate periodontal disease) là một nguy cơ cho sức khỏe tổng quát và cho sự thoải mái của một người. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy viêm nha chu làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, sinh con sớm, nhẹ cân và bệnh đái tháo đường.

1.1. Những yếu tố nguy cơ nền

- Chủng tộc.
- Giới tính.
- Yếu tố gen/di truyền.

- Suy giảm miễn dịch bẩm sinh.
- Rối loạn chức năng thực bào.
- Hội chứng Down.
- Hội chứng Papillon-Lefevre.
- Hội chứng Ehlers-Danlos.

1.2. Những yếu tố nguy cơ “mắc phải và môi trường”

- Vệ sinh răng miệng kém.
- Tuổi tác.
- Thuốc trị bệnh.
- Hút thuốc lá.
- Stress.
- Rối loạn miễn dịch mắc phải.
- Bệnh nội tiết mắc phải.
- Bệnh viêm nhiễm.
- Suy dinh dưỡng.

1.3. Vi khuẩn đặc hiệu kết hợp với viêm nha chu

- Nguyên nhân rõ rệt:
 - + *Actinobacillus actinomycetemcomitans*.
 - + *Porphyromonas gingivalis*.
 - + *Bacteroides forsythus*.
- Nguyên nhân trung bình:
 - + *Campylobacter rectus*.
 - + *Eubacterium nodatum*.
 - + *Fusobacterium nucleatum*.
 - + *Prevotella intermedia*.
 - + *Peptostreptococcus micros*.
 - + *Streptococcus intermedius-complex*.
 - + *Treponema denticola*.

Sự hiểu biết về vi khuẩn thay đổi không ngừng. Đồng thời với việc làm rõ vai trò của chủ thể trong sự phát sinh và phát triển của bệnh nha chu. Hai tài liệu mới nhất đã tóm tắt quá trình phát triển vừa nêu: khởi đầu khi lượng vi khuẩn tập trung đủ số lượng, ta có viêm ở các mạch máu nhỏ. Kế đó, vi khuẩn và những sản phẩm của vi khuẩn đặc

biệt là những lipopolysaccharide (LPS) vượt qua hàng rào biểu mô bám dính và biểu mô túi nha chu để đến mô liên kết và các mạch máu. Kể đó những thành phần của máu và huyết thanh thâm nhập vào mô liên kết, những lympho bào B và T, những tương bào và những đại thực bào xuất hiện ở mô nha chu. Những LPS tương tác với những monocyte và những đại thực bào hoạt hóa những tế bào này tổng hợp ra những hiện tượng lớn IL-1, yếu tố hoại tử alpha TNF α (tumor necrosis factor alpha), prostaglandin E₂(PGE₂) và matrix metalloproteinases (MMP₅), PGE₂, IL-1 và TNF α có vai trò trung gian thúc đẩy tiêu xương ổ răng biểu hiện qua những dấu chứng lâm sàng như mất bám dính và răng lung lay.

2. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CHỦ THỂ TRONG BỆNH NHA CHU

Viêm ở các mạch máu nhỏ.

Vi khuẩn và sản phẩm của vi khuẩn, đặc biệt là *lypopolysaccharide* (LPS) vượt qua biểu mô bám dính và biểu mô túi đến mô liên kết và các mạch máu.

Tất cả các thành phần của máu và huyết thanh thâm nhập vào mô liên kết.

Những lympho bào B và T, những tương bào, những đại thực bào xuất hiện.

LPS tương tác với những monocyte và những đại thực bào hoạt hóa những tế bào tổng hợp lượng lớn IL-1, TNF α , PGE₂, MMP₅.

PGE₂, IL-1, TNF α thúc đẩy tiêu xương ổ răng.

MMP₅ làm thoái hệ thống collagen của mô liên kết.

Phá hủy ở mô liên kết và chuyển hóa xương đưa đến những dấu chứng lâm sàng.

2.1. Tóm tắt về những phát hiện mới

Những tip vi khuẩn đặc hiệu là nguyên nhân của viêm nha chu.

Đáp ứng viêm nhiễm miễn dịch của chủ thể, mặc dù có tính bảo vệ, là nguyên nhân gây hủy mô trong viêm nha chu.

2.2. Quan niệm 1998 về bệnh nha chu

Những yếu tố nguy cơ đặc hiệu “nền”, mắc phải và môi trường góp phần làm tăng mức cảm đối với viêm nha chu.

Viêm nha chu là một yếu tố nguy cơ chủ yếu cho bệnh tim mạch, sinh con sớm, nhẹ cân.

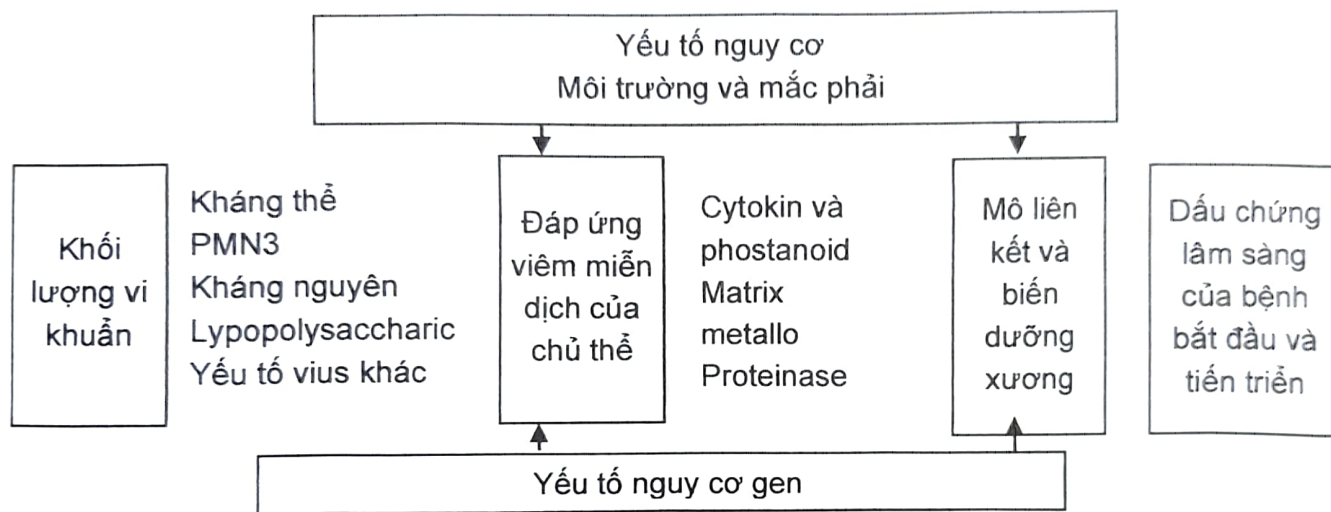
Những thay đổi ở tầm mức tế bào là có thể điều chỉnh được.

Đáp ứng viêm nhiễm miễn dịch của chủ thể, mặc dù có tính bảo vệ, là nguyên nhân gây hủy mô trong viêm nha chu.

Viêm nha chu tiến triển theo các giai đoạn của chất bám dính.

Tính miễn cảm đối với viêm nha chu thay đổi theo tùy người và răng.

3. MÔ HÌNH CHUNG CỦA VIÊM NHA CHU



Sơ đồ 5.1. Mô hình viêm nha chu.

Viêm nha chu tiến triển theo những giai đoạn mất bám dính.

Tính miễn cảm đối với viêm nha chu thay đổi theo tùy người và răng.

Những yếu tố nguy cơ đặc hiệu “nền”, mắc phải và môi trường góp phần làm tăng miễn cảm đối với viêm nha chu.

Viêm nha chu là một yếu tố nguy cơ chủ yếu cho bệnh tim mạch, sinh sớm và nhẹ cân.

Những thay đổi ở tầm mức tế bào là có thể điều chỉnh được.

Bài 6.

PHÂN LOẠI BỆNH NHA CHU

Bệnh nha chu gồm viêm nướu và viêm nha chu: trong đó viêm nướu là sự viêm nhiễm mô nướu, còn viêm nha chu là quá trình bệnh lý tấn công mô nha chu sâu (Ce, dây chằng, xương ổ R) gây ra viêm nha chu với hiện tượng tiêu xương ổ, nếu không điều trị sẽ dẫn đến mất răng. Bệnh nha chu là bệnh do vi khuẩn gây ra, hậu quả dẫn đến sự thành lập những sang thương viêm nhiễm dưới ảnh hưởng của hệ thống miễn dịch.

1. PHÂN LOẠI BỆNH VỀ NƯỚU

Viêm nướu là quá trình bệnh lý tấn công vào mô nha chu nông (nướu răng). Năm 1965, Loe và cộng sự cho rằng màng bám vi khuẩn là nguyên nhân chính gây viêm nướu. Như vậy, viêm nướu là phản ứng viêm nhiễm không đặc hiệu của mô nha chu đối với hệ tập khuẩn (Thelade, 1986). Theo ARMITAGE (1999), bệnh về nướu được phân loại như sau:

1.1. Bệnh nướu do màng bám vi khuẩn

1.1.1. Viêm nướu do màng bám

- Không có các yếu tố tại chỗ.
- Có sự hiện diện của yếu tố tại chỗ.

1.1.2. Bệnh nướu bị biến đổi do yếu tố toàn thân

- Phối hợp với hệ thống nội tiết:
 - + Tuổi dậy thì phối hợp với viêm nướu.
 - + Chu kỳ kinh nguyệt kết hợp với viêm nướu.
 - + Thời kỳ mang thai phối hợp:
 - Viêm nướu.
 - Pyogenic granuloma.
 - + Tiểu đường kết hợp viêm nướu.
- Phối hợp với rối loạn đông máu:
 - + Ung thư máu kết hợp với viêm nướu.
 - + Bệnh khác.

1.1.3. Bệnh nướu bị biến đổi do dùng thuốc

- Thuốc ảnh hưởng lên sự phì đại nướu.
- Thuốc ảnh hưởng viêm nướu:
 - + Thuốc ngừa thai kết hợp viêm nướu.
 - + Thuốc khác.

1.1.4. Bệnh nướu bị biến đổi do suy dinh dưỡng

- Thiếu acide ascorbique và viêm nướu.
- Bệnh khác.

1.2. Bệnh nướu không do màng bám

1.2.1. Bệnh nướu có nguyên nhân do các vi khuẩn đặc hiệu

- *Neisseria gonorrhoea* kết hợp với sang thương nướu.
- *Treponema pallidum*.
- *Streptococcus*.
- Loại vi khuẩn khác.

1.2.2. Bệnh nướu có nguyên nhân do virus

- Nhiễm virus herpes:
 - + Viêm nướu miệng do herpes (nguyên phát).
 - + Viêm nướu miệng tái phát do herpes.
 - + Nhiễm khuẩn *Varicella - Zoster*.
- Các loại khác.

1.2.3. Bệnh nướu có nguyên nhân do nấm

- Nấm candida.
- Đường ban đỏ ở nướu.
- Histoplasmosis.
- Các loại khác.

1.2.4. Bệnh nướu có nguyên nhân di truyền

- U xơ do di truyền.
- Các loại khác.

Bài 7.

VIÊM NƯỚU DO NGUYÊN NHÂN TẠI CHỖ, TOÀN THÂN

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ VIÊM NƯỚU

Viêm nướu là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh về nha chu (> 80%). Có thể xảy ra ở bất kỳ người nào và bất kỳ độ tuổi nào.

Viêm nướu là tình trạng viêm chi khu trú ở mô nha chu bề mặt bao gồm lớp biểu mô bên ngoài, lớp mô liên kết kề cận. Các mô khác như xương ổ, dây chằng nha chu, màng nha chu hay xê măng không bị ảnh hưởng.

Viêm nướu là sự đáp ứng bình thường có tính cách bảo vệ của mô nha chu trước một loại kích thích tại chỗ là vi khuẩn.

Viêm nướu là bệnh có thể hoàn nguyên, nếu nguyên nhân được loại trừ.

Trong bệnh viêm nướu không có hiện tượng mất bám dính.

Viêm nướu là một bệnh viêm đặc trưng bởi:

- Thay đổi về màu sắc, hình dạng và vị trí.
- Thay đổi về cấu trúc bề mặt.
- Chảy máu, phù nề.
- Đau hay không đau.
- Thay đổi về mô học.

Nguyên nhân: do vi khuẩn trong mảng bám, các yếu tố khác chỉ làm thay đổi hình ảnh lâm sàng và sự phát triển của viêm nướu có sẵn.

2. NHỮNG DẤU CHỨNG ĐẶC TRƯNG CỦA VIÊM NƯỚU

Vị trí viêm: liên hệ tới nướu răng, nơi có kích thích tại chỗ như vi khuẩn, vôi răng, nhồi nhét thức ăn... Viêm nướu có thể khu trú trên một răng, một nhóm răng hay toàn bộ hai hàm.

Những thay đổi về màu sắc: từ màu hồng san hô đổi sang màu đỏ, đỏ sẫm, đỏ xanh xám.

Những thay đổi về hình dạng: bờ nướu chuyển sang phù nề, gai nướu sưng.

Những thay đổi về vị trí: bờ dưới gai nướu sưng phù nề có thể lên đến phần lồi của thân răng. Có thể tạo túi giả (biểu mô bám dính không di chuyển).

Thay đổi về cấu trúc bề mặt: bề mặt nướu giảm hay mất hẳn lâm tẩm da cam, mất hình dạng gai nướu và khe nướu.

Chảy máu: nướu viêm dễ chảy máu khi thăm khám hay khi đánh răng, có thể có chảy máu tự phát.

Tiết dịch: tăng tiết dịch nướu và dịch viêm.

Đau: viêm nướu thường không đau, nhưng ở giai đoạn cấp gây đau. Nướu sưng đỏ.

Nguyên nhân: do vi khuẩn tích tụ ở khe nướu, nướu viêm có thể trở lại tình trạng ban đầu khi điều trị tích cực và nguyên nhân được loại bỏ.

3. ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU VỀ MÔ HỌC CỦA VIÊM NƯỚU

Nướu răng lành mạnh: trong lớp biểu mô bám dính và khe nướu có ít bạch cầu đa nhân trung tính, một ít đại thực bào và tương bào.

Nướu viêm mạn: cũng giống hiện tượng viêm nhiễm khác, viêm nướu trải qua 3 giai đoạn:

3.1. Giai đoạn khởi đầu: ngày 1-4

Vi khuẩn và sản phẩm của vi khuẩn trong mảng bám hiện diện ở khe nướu và cổ răng phá hủy lớp biểu mô và cầu nối liên bào (nơi nối kết các tế bào biểu mô lại với nhau). Tạo một đường vào cho vi khuẩn và độc tố tấn công mô liên kết bên dưới.

Thoát dịch và hiện diện nhiều dịch nướu trong khe nướu.

Mạch máu ở phía dưới của biểu mô bám dính viêm. Bạch cầu từ mạch máu di chuyển đến xung quanh thành mạch, sát với lớp biểu mô bám dính, nếu viêm không được khắc phục, những thay đổi ban đầu này sẽ tạo ra sang thương.

Mất chất collagen xung quanh mạch máu, gần thân răng.

Hình thành túi giả.

Biểu mô bám dính bắt đầu tăng sinh với các gai biểu mô đâm vào mô liên kết bên dưới.

Sợi collagen bị phá hủy, kèm theo sự hình thành collagen mới.

3.2. Giai đoạn hình thành sang thương: 7-14 ngày

Phản ứng viêm cấp tiếp tục, sợi collagen bị phá hủy ngày càng nhiều hơn (70%), tăng tiết dịch ngày càng nhiều. Bạch cầu đa nhân trung tính xuất hiện dày đặc trong biểu mô bám dính và khe nướu.

Gai, nhú của tế bào biểu mô lặn sâu vào trong mô liên kết.

Tích tụ nhiều tế bào lympho dưới biểu mô bám dính.

Dịch nướu tăng tiết, sợi collagene bị phá hủy, xuất hiện ngày càng nhiều bạch cầu đa nhân trung tính trong khe nướu.

Mô liên kết bị tâm nhiễm viêm, mất collagene ngày càng lan rộng.

3.3. Giai đoạn sang thương ổn định: ngày 14 trở đi

Giai đoạn viêm mạn, mạch máu sưng phồng và sung huyết, có hiện tượng giảm oxy huyết, nướu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh do thiếu oxy.

Đặc điểm giai đoạn này là bào tương chiếm ưu thế, chúng tập trung sát biểu mô bám dính và biểu mô khe nướu.

Có sự hiện diện của tế bào miễn dịch bên ngoài mạch máu trong mô liên kết.

Sợi collagen bị phá hủy phần lớn, chưa có sự tiêu xương.

Có sự dày lên của biểu mô của túi làm mất sự tiếp xúc với bề mặt răng, cho phép vi khuẩn di chuyển về chóp răng.

Ở vùng khe nướu có sự hiện diện: vi khuẩn, xác tế bào vi khuẩn, vôi răng, bạch cầu, xác bạch cầu... Vi khuẩn, nội độc tố của vi khuẩn xâm nhập bên trong mô.

Đây là giai đoạn cuối cùng để can thiệp, nếu không sẽ có tổn thương nặng và có thể chuyển sang viêm nha chu.

4. VIÊM NƯỚU QUÁ SẴN DO DÙNG THUỐC

4.1. Phenytoin

Phenytoin là loại thuốc chống động kinh dùng điều trị bệnh động kinh và một số dạng bệnh thần kinh khác. Bệnh nhân sử dụng thuốc này có tỷ lệ viêm nướu quá sản khoảng từ 3-84,5%, thường thấy ở những bệnh nhân trẻ. Liều lượng thuốc và số lần sử dụng không ảnh hưởng đến sự xuất hiện cũng như mức độ nặng nhẹ của bệnh.

Dấu chứng lâm sàng:

Khởi đầu sang thương là sự sưng nhẹ không đau nhức ở bề mặt nướu viền và gai nướu. Quá trình sưng tiếp tục, nướu viền và gai nướu sưng ngày càng lớn hơn với khuynh hướng che phủ một phần thân răng hoặc có thể che phủ cả mặt nhai hay cạnh cắn của răng.

Khi không có sự phối hợp của yếu tố gây viêm sang thương có dạng hình tròn, cứng, dai, màu hồng nhạt, bề mặt trơn nhẵn, ít có nguy cơ chảy máu. Sang thương có giới hạn bằng đường rãnh chạy dọc theo phần sưng phân cách giữa mô nướu lành mạnh và mô nướu bị triển dướng.

Sưng nướu có thể xuất hiện khi không có kích thích tại chỗ, nhưng cũng có thể không xuất hiện ở miệng bệnh nhân có nhiều kích thích tại chỗ.

Nướu quá sản thường ở dạng toàn thể, nhưng nặng hơn ở vùng răng cửa, nướu mất ngoài các răng cửa có thể có nhiều u. Khối sưng chỉ xuất hiện ở vùng còn răng và sẽ biến mất sau khi nhổ răng. Rất hiếm khi thấy quá sản trên niêm mạc miệng.

Khi kết hợp với các yếu tố gây viêm (mảng bám vi khuẩn, kích thích tại chỗ...) các khối sưng có tình trạng viêm đi viêm lại từ mức trung bình đến nặng, cấp tính. Đôi khi kèm theo cảm giác đau. Có sự hiện diện của túi giả từ 4 - 7 mm. Cần lưu ý mảng bám vẫn là yếu tố cơ bản nhất, thuốc chỉ giữ vai trò làm biến đổi sự đáp ứng của mô trong quá trình viêm.

4.2. Cyclosporine

Cyclosporine là một tác nhân miễn dịch được sử dụng ở những bệnh nhân ghép cơ quan và điều trị một số bệnh tự miễn. Cơ chế tác động của thuốc chưa rõ ràng, chúng tác động một cách chọn lọc lên các tế bào T là tế bào tham gia trong các phản ứng miễn dịch.

Về mặt lâm sàng, quá sản nướu do dùng Cyclosporine có biểu hiện giống như dùng Phenytoin. Nướu sưng khởi đầu ở các gai nướu mất ngoài vùng răng cửa và có thể tiến triển che phủ hoàn toàn thân răng. Sang thương có màu hồng sẫm chắc với bề mặt gồ ghề lấm tấm hạt, ít có nguy cơ chảy máu. Các trường hợp phối hợp với yếu tố gây viêm thì có triệu chứng của viêm.

4.3. Nifedipine

Nifedipine là thuốc tác động trực tiếp lên động mạch vành làm tăng lượng máu cung cấp cho cơ tim, dùng điều trị bệnh tim mạch và bệnh tăng huyết áp. Biểu hiện lâm sàng tương tự như viêm nướu quá sản do dùng thuốc Phenytoin và Cyclosporine.

Ngoài ra, còn có sưng nướu nguyên phát, chưa rõ nguyên nhân có thể liên quan đến di truyền. Sưng nướu ảnh hưởng lên nướu dính, nướu viền và gai nướu, bề mặt nướu sẫm chắc lồi lõm nhọn như đá cuội. Trường hợp nặng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cung hàm. Viêm thứ cấp làm thay đổi màu sắc nướu.

Điều trị:

Ngưng sử dụng thuốc, nếu khối u ở dạng mạn không mất hẳn sau khi ngưng thuốc thì phải phẫu thuật cắt bỏ và tạo hình nướu.

Điều trị bằng phẫu thuật rất dễ tái phát nếu không ngưng sử dụng thuốc.

Viêm chính là tiền đề cho nướu quá sản, nên phải loại bỏ mọi kích thích, kiểm soát viêm. Việc kiểm soát mảng bám ở những bệnh nhân này rất khó khăn có thể dẫn tới phôi hợp của viêm nướu cấp.

Mô bệnh học:

Quá sản xảy ra cả biểu mô và mô liên kết. Biểu mô bị tăng sừng hóa, các nhú biểu mô lún sâu hơn vào lớp mô liên kết bên dưới. Sự gia tăng bất thường của các tế bào sợi, nằm trong một chất gian bào bình thường, các tế bào vẫn giữ nguyên hình dáng. Lớp mô liên kết dày đặc các bó sợi collagen, có nhiều mạch máu tân sinh.

Quá sản nướu do sử dụng thuốc, tỷ lệ các tế bào sợi và sợi collagen bằng nhau (giống tỷ lệ ở nướu răng bình thường), nên nướu quá sản dai chắc và không thay đổi màu sắc.

5. VIÊM NƯỚU DO ẢNH HƯỞNG CỦA HORMON

5.1. Viêm nướu viêm

Hormon Steroid có thể làm biến đổi và khuếch đại hình ảnh viêm có sẵn, khởi đầu vào tháng thứ 2, cao điểm vào tháng thứ 7, 8. Có sự tăng sinh nhanh chóng của những vi khuẩn đặc hiệu như những *Bacteroides* ở những bệnh nhân có thai.

Vi khuẩn liên hệ: *Prevotella Intermedia*, Hormon có thể là chất gây tăng sinh cho loại vi khuẩn này. Tăng Estrogen và Progesteron có thể ảnh hưởng đến các mao mạch và làm tăng sản xuất các chất trung gian gây viêm.

Dấu chứng lâm sàng: giống viêm nướu thông thường, viêm toàn thể, có thể nặng hơn ở gai nướu, nướu đỏ sậm màu và bờ, bề mặt trơn láng, dễ chảy máu.

Nhiều tác giả nhận thấy những đáp ứng ở mô nướu với hormon steroid cũng giống như những quan sát được ở bộ phận sinh dục, hoặc ở các tuyến vú trong cùng một thời điểm.

5.2. U nướu thai nghén

Là phản ứng viêm do kích thích tại chỗ được bổ sung thêm với điều kiện bản thân. Thường xuất hiện ở tháng thứ ba, cũng có thể sớm hơn. U có dạng cây nấm, bờ viền xung quanh mỏng, u thường thấy ở gai nướu, có khuynh hướng phát triển sang hai răng kế bên do áp lực của môi má. Khối u đỏ sậm trơn láng bóng. Không đau trừ khi có kích thích hay bị loét do ăn nhai, khối u gây tích tụ vi khuẩn làm nặng thêm. Sau khi sinh có thể trở lại trạng thái ban đầu.

Hình ảnh mô học: mô liên kết có nhiều mạch máu lan tỏa và các tân sinh tế bào nội mô. Ở phần biểu mô lớp tế bào gai dày lên, bề mặt biểu mô bị sừng hóa toàn bộ. Đặc trưng của viêm nướu thai nghén là mạch máu tăng sinh liên hệ với viêm, tuy nhiên sự tăng sinh quá mức so với phản ứng bình thường của mô nướu đối với các kích thích tại chỗ. Hình ảnh vi thể của viêm nướu thai nghén cũng không có khác biệt nhiều so với các loại viêm nướu do kích thích tại chỗ, do mảng bám vi khuẩn.

5.3. Viêm nướu ở tuổi dậy thì

Xuất hiện ở hai phía, thường hiện diện ở vùng có kích thích tại chỗ. Viêm quá mức bình thường so với kích thích tại chỗ (thường là rất ít), hay gặp ở gai nướu và nướu viêm. Nướu ở mặt ngoài sưng lớn hơn nướu mặt trong (do hoạt động của lưỡi và sự trượt của thức ăn, ngăn cản sự tích tụ của mảng bám). Khi qua tuổi dậy thì (11 - 17 tuổi) viêm giảm một cách tự phát nhưng không thể mất hoàn toàn. Nguyên nhân do thay đổi hormon.

Bài 8.

THAY ĐỔI MÔ HỌC TỪ VIÊM NƯỚU SANG VIÊM NHA CHU

1. MÔ BỆNH HỌC CỦA BỆNH NHA CHU

1.1. Mô nướu lành mạnh trên lâm sàng

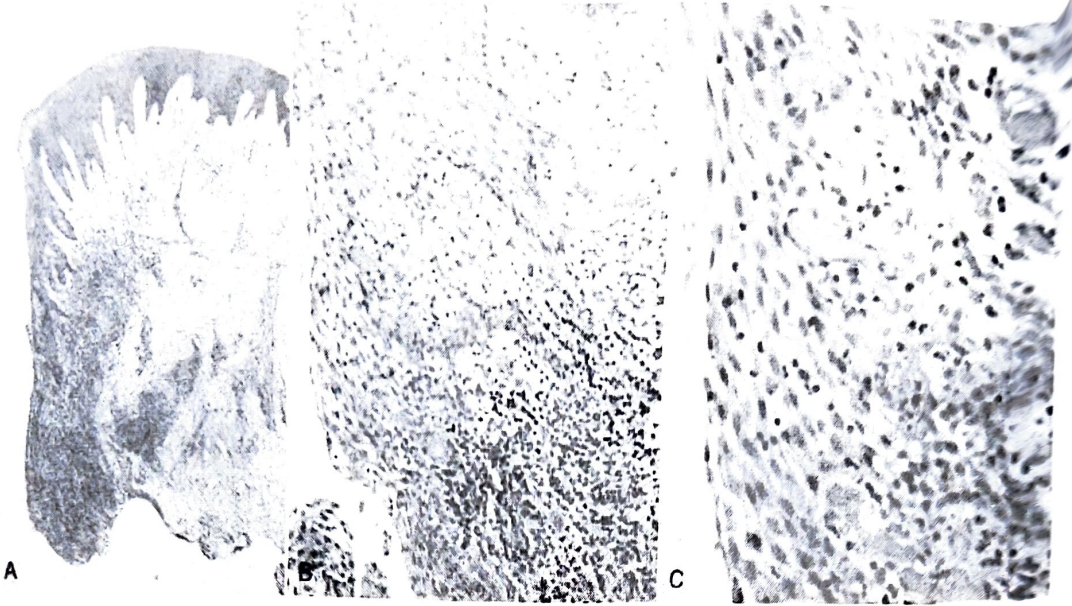
Mô nướu lành mạnh trên lâm sàng thì hồng hào, không sưng, không viêm và bám chặt vào răng hoặc xương bên dưới, rất ít khi chảy máu khi thăm dò. Điều cần lưu ý là nướu lành mạnh trên lâm sàng, thì mô liên kết cũng có ít nhất vài tế bào viêm, đặc biệt là bạch cầu trung tính. Bạch cầu trung tính tiếp tục di cư xuyên qua mô liên kết và đi qua biểu mô bám dính để vào khe nướu/túi nướu. Cùng với sự di cư của bạch cầu trung tính xuyên qua mô nướu, tế bào lympho và đại thực bào cũng tích tụ. Sự hiện diện của bạch cầu trong mô liên kết do các kích thích hóa hướng động tạo bởi màng sinh học dưới nướu và sản phẩm của vi khuẩn và yếu tố hóa ứng động tạo từ chủ thể.

Ở mô khỏe mạnh trên lâm sàng, sự ổn định cân bằng giữa sự viêm ở mức độ thấp trong mô và sự hiện diện liên tục của vi khuẩn có thể tồn tại trong nhiều năm hoặc thực sự là toàn bộ đời sống con người. Các biểu hiện lâm sàng của viêm nướu (đỏ, sưng và chảy máu khi thăm dò) không tiến triển vì một số cơ chế bảo vệ bẩm sinh và cơ học, bao gồm:

- Sự duy trì của hàng rào biểu mô còn nguyên vẹn (biểu mô kết nối và biểu mô khe nướu).
- Lượng dịch nướu chảy ra từ khe nướu (có tác dụng pha loãng và rửa sạch).
- Sự bong tróc tế bào biểu mô bề mặt của biểu mô khe nướu và biểu mô bám dính.
- Sự hiện diện của bạch cầu trung tính và đại thực bào trong khe nướu, để thực hiện quá trình đại thực bào.

- Kháng thể trong dịch nướu (mặc dù không rõ nó có thực sự tác dụng hay không).

Khi sự tích tụ mảng bám tăng, làm cơ chế bảo vệ này quá tải, viêm cũng như các biểu hiện viêm nướu sẽ xuất hiện.



Hình 8.1. Mô học của viêm nướu.

(Nguồn: Carranza's Clinical Periodontology, 2015).

Mô học của viêm nướu khi nhuộm hematoxylin và eosin. Trong các trường hợp răng ở bên trái của hình ảnh.

A. Độ phóng đại thấp của nướu cho thấy biểu mô kết nối và biểu mô khe nướu tăng sản với một tế bào viêm dày đặc xâm nhập vào các mô liên kết lân cận.

B. Độ phóng đại trung bình của mô liên kết biểu mô. Giao diện cho thấy nhiều tế bào viêm nội mô cùng với phù nội bào. Các mô liên kết chứa mao mạch giãn (tăng huyết áp), và có sự thâm nhập một tế bào viêm.

C. Độ phóng đại cao: cho thấy bạch cầu trung tính và tế bào lympho xuyên qua biểu mô khe nướu.

1.2. Mô bệnh học của viêm nướu và viêm nha

Nghiên cứu của Page và Schroeder đã mô tả các thay đổi xảy ra trên mô nướu với bốn giai đoạn: tổn thương khởi đầu, sớm, thành lập và tiến triển. Tổn thương ban đầu tương đương với mô lâm sàng lành mạnh (nhưng viêm nhẹ), tổn thương sớm tương đương với giai đoạn đầu của viêm nướu (rõ trên lâm sàng), tổn thương thành lập tương đương với viêm nướu mạn và tổn thương tiến triển đánh dấu chuyển tiếp sang viêm nha chu với mất bám dính và tiêu xương. Lưu ý quan trọng là những điều trên chỉ là miêu tả mô học và chúng không có vai trò trong chẩn đoán lâm sàng.

Đặc trưng cơ bản các giai đoạn mô học của bệnh viêm nướu và viêm nha chu:

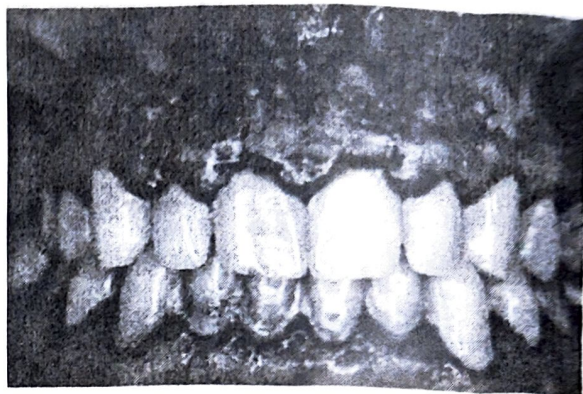
- Tổn thương ban đầu (tương đương với mô nướu khỏe mạnh trên lâm sàng).
 - + Tăng nhẹ tính thấm thành mạch và giãn mạch.
 - + Dịch nướu chảy ra ngoài khe nướu.

- + Sự di cư của bạch cầu, chủ yếu là bạch cầu trung tính với số lượng tương đối nhỏ thông qua mô liên kết nước, biểu mô bám dính vào khe nước.
- Tổn thương sớm (tương đương viêm nước giai đoạn sớm và có biểu hiện lâm sàng):
 - + Tăng tính thấm thành mạch, giãn mạch và dịch nước.
 - + Một lượng lớn bạch cầu xâm nhập (phần lớn bạch cầu trung tính và tế bào lympho).
 - + Sự thoái hóa của các nguyên bào sợi.
 - + Phá hủy collagen gây ra tiêu mất collagen ở cũng mô liên kết.
 - + Sự gia tăng biểu mô bám dính và biểu mô khe nước.
- Tổn thương thành lập (tương đương với viêm nước mạn tính, chính thức):
 - + Tế bào viêm xâm nhập dày đặc (tương bào, tế bào lympho, bạch cầu trung tính).
 - + Tích tụ tế bào viêm trong mô liên kết.
 - + Gia tăng sự phóng thích MMPs và tiêu thể từ bạch cầu trung tính.
 - + Có sự tiêu collagen rõ và tăng trưởng của biểu mô.
 - + Hình thành túi biểu mô chứa nhiều bạch cầu trung tính.
- Tổn thương tiến triển (biểu hiện sự chuyển tiếp từ viêm nước sang viêm nha chu):
 - + Ưu thế của bạch cầu trung tính trong túi biểu mô và túi nha chu.
 - + Tế bào viêm xâm nhập dày đặc hơn mô liên kết (chủ yếu là tương bào).
 - + Sự di chuyển về phía chóp của biểu mô bám dính để duy trì sự nguyên vẹn hàng rào biểu mô.
 - + Tiếp tục phá hủy collagen dẫn đến tiêu một lượng lớn collagen của mô liên kết.
 - + Tiêu xương ổ răng do hủy cốt bào.

2. SỰ THAY ĐỔI TỪ KHE NƯỚC SANG TÚI NHA CHU

Vi khuẩn ở mảng bám tích tụ ở viền nước và khe nước với số lượng và thời gian tiếp xúc đủ để gây ra đáp ứng miễn dịch, biểu hiện lâm viêm nước. Sự thay đổi từ khe nước bình thường sang túi nha chu bệnh lý có liên quan đến sự khác nhau về tỷ lệ các vi khuẩn trong mảng bám. Nước khỏe mạnh thì khe nước có ít vi khuẩn, chủ yếu là cầu khuẩn và sợi khuẩn. Nước bị bệnh liên quan đến sự gia tăng số lượng xoắn khuẩn và trực khuẩn. Tuy nhiên, hệ vi khuẩn ở vị trí bệnh không thể ước đoán được mất bám dính và mất xương trong tương lai vì chỉ một mình nó không đủ để khởi phát hay tiến triển viêm nha chu. Sự hình thành túi nha chu bắt đầu từ những thay đổi viêm trong mô liên kết ở thành khe nước. Dịch và tế bào viêm gây phá hủy mô liên kết chung quanh, bao

gồm các sợi nước. Sợi collagen và biểu mô kết nối bị phá hủy về phía chóp và vùng này chứa đầy tế bào viêm và dịch phù.



Hình 8.2. Hình ảnh mô học viêm nha chu mạn tính.
(Nguồn: *Carranza's Clinical Periodontology*, 2015)

Khi viêm nha chu xác lập, ở phương diện mô học hình ảnh sang thương tiến triển được mô tả như sau:

- Trong mô có chứa nhiều tương bào, còn sang thương ổn định thì đa số là tế bào lympho T.
- Mô liên kết thâm nhiễm gia tăng.
- Các bó sợi collagen ở vùng nước đối diện với mặt chân răng bị phá hủy. Điều này nói lên sự gia tăng sản xuất enzym, ví dụ như collagenase.
- Biểu mô khe nước biến đổi thành biểu mô túi nha chu. Hiện tượng này làm cho biểu mô bám dính di chuyển về phía chóp gốc và có sự phá hủy dây chằng nha chu, tiêu xương.

3. SỰ PHÁ HỦY XƯƠNG DO VIÊM NƯỚC LAN RỘNG

Các yếu tố liên quan quan đến phá hủy xương là vi khuẩn và các chất trung gian của phản ứng viêm. Tất cả viêm nha chu đều bắt đầu từ viêm nước nhưng không phải tất cả viêm nước đều tiến triển sang viêm nha chu. Rõ ràng một số trường hợp viêm nước không bao giờ chuyển sang viêm nha chu và một số khác trải qua viêm nước nhẹ rồi nhanh chóng tiến triển sang viêm nha chu. Cho đến nay, chưa có dữ liệu nào cho thấy viêm nha chu phát triển trên nền không viêm nước. Các sản phẩm của vi khuẩn và chất trung gian viêm tác động trực tiếp lên tế bào tạo xương, gây ức chế và giảm số lượng tế bào này cũng như kích thích các tế bào tiền thân của tế bào xương chuyển

thành tế bào hủy xương. Các chất trung gian viêm đóng vai trò gây sự tiêu xương trong bệnh nha chu là prostaglandins, IL-1 và TNF- α .

Theo nghiên cứu của Loc (1986) trên những công nhân làm trà ở Sri Lanka không chăm sóc răng miệng, tác giả nhận thấy tốc độ phá hủy xương ở mặt ngoài là 0,2 mm/năm và ở mặt bên là 0,3 mm/năm khi bệnh tiến triển không điều trị. Tuy nhiên, tốc độ hủy xương có thể thay đổi tùy thuộc vào loại bệnh nha chu. Tác giả nhận thấy có thể chia bệnh nhân làm ba nhóm dựa trên tốc độ mất xương ở mặt bên:

- Khoảng 8% bệnh nhân có bệnh nha chu tiến triển nhanh, mất xương hằng năm từ 0,1 - 1 mm.
- Khoảng 81% bệnh nhân có bệnh nha chu tiến triển trung bình, mất xương hằng năm từ 0,05 đến 0,5 mm.
- Còn lại 11% bệnh nhân có nha chu tiến triển chậm hoặc không tiến triển, mất xương hằng năm từ 0,05 đến 0,09 mm.

Bài 14.

KHÁM MÔ NHA CHU VÀ CÁC CHỈ SỐ NHA CHU TRONG NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

1. MỞ ĐẦU

Khám răng miệng không được xem là toàn diện nếu như không đánh giá tình trạng mô nha chu. Việc khám và thu thập đúng tình trạng mô nha chu rất cần thiết để có một chẩn đoán đúng và tiên lượng về bộ răng bệnh nhân, từ đó xây dựng kế hoạch điều trị thích hợp.

Khám mô nha chu bao gồm các bước sau:

- Đánh giá các yếu tố gây bệnh.
- Khám mô nướu.
- Khám và đánh giá sự phá hủy cấu trúc mô nha chu.
- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến điều trị.

2. CÁC BƯỚC KHÁM MÔ NHA CHU

2.1. Đánh giá các yếu tố gây bệnh

Trong những thập niên qua, ngành nha khoa đã xác định rõ ràng bệnh nha chu là bệnh nhiễm khuẩn hỗn hợp của nhiều loại vi khuẩn đặc hiệu. Vì vậy, trong khi khám mô nha chu, cần đánh giá mức độ kiểm soát mảng bám của bệnh nhân và những yếu tố lưu giữ giữ mảng bám vi khuẩn. Ví dụ như ghi nhận một miếng trám dư ở dưới nướu. Đây là vị trí khó làm sạch và tạo điều kiện cho vi khuẩn tăng sinh. Tương tự, ta cần phát hiện tình trạng răng mọc chen chúc, sang thương vùng kẽ, đường hoàn tất của phục hình không khít khao.

Chúng ta nên ghi nhận cả trường hợp khám thấy mảng bám vi khuẩn ít hoặc không thấy. Vì trong một số trường hợp đặc biệt, viêm nha chu thanh thiếu niên khu trú, viêm nha chu kháng - mô nha chu bị phá hủy nhiều nhưng mảng bám vi khuẩn thấy được trên lâm sàng rất ít.

2.2. Khám mô nướu

Khám nướu là bước khám đầu tiên để phát hiện mô nha chu bị nhiễm trùng. Khi các yếu tố gây bệnh cho mô nha chu tập trung dưới nướu thì kỹ chủ sẽ đáp ứng bằng các

phản ứng viêm thấy được trên lâm sàng. Vị trí nướu bị nhiễm khuẩn có một trong bốn dấu chứng sau: thay đổi màu, sưng hay phù nề, chảy máu khi thăm dò với áp lực vừa phải và xuất tiết dịch.

Hầu hết các trường hợp nướu có màu đỏ (sậm, tươi). Màu đỏ của nướu do sự gia tăng cung cấp máu ở vị trí nhiễm khuẩn. Cách tốt nhất để phát hiện sự đổi màu nướu là so sánh màu viền nướu dính của răng kế cận.

Nướu sưng, phù nề do tích tụ dịch trong mô liên kết. Dịch này chủ yếu là huyết thanh từ các mạch máu thoát ra. Phát hiện nướu phù nề bằng cách ghi nhận sự thay đổi của nướu về: đường viền, hình dạng, độ săn chắc và nướu ôm sát vào răng. Còn ở vị trí nướu phù nề thì viền nướu thường tròn, mô xung quanh lỏng lẻo, hơi to lên, nướu không ôm chặt vào răng.

Các dấu chứng nướu đỏ hay phù nề là các dấu chứng chủ quan của viêm nướu. Trong khi thăm dò ta phát hiện có chảy máu hay không? Đó là triệu chứng khách quan. Chảy máu khi thăm dò là do lớp biểu mô khe nướu bị nhiễm trùng quá mỏng hay có vết loét. Một khe nướu khỏe mạnh thì không chảy máu khi thăm dò bằng cây đo túi. Do đó, chảy máu khi thăm dò là một cách phát hiện vị trí bị nhiễm trùng đơn giản, không gây đau và nhanh. Chảy máu khi thăm dò rất hữu ích trong việc phát hiện những vị trí nhiễm khuẩn nằm sâu ở đáy túi nha chu nhưng nếu chỉ nhìn thấy bằng mắt thì nướu biểu hiện như nướu khỏe mạnh.

Dấu chứng cuối cùng là dịch hay mủ tiết ra từ khe nướu. Dịch khe nướu gồm các tế bào viêm (hầu hết là bạch cầu đa nhân trung tính) và protein huyết thanh. Ngoài ra, còn có vi khuẩn, enzym, kháng thể... có 3 phương pháp để phát hiện dịch nướu.

- Cô lập vị trí, làm khô nhẹ bằng hơi xịt và đưa một mảnh giấy thấm nhỏ vào khe nướu hay túi nha chu, để trong vòng 3-5 phút. Sau đó, lấy mảnh giấy ra và đưa vào máy đo đo thể tích dịch được hút vào băng giấy.

- Cô lập và làm khô. Đợi cho đến khi thấy dịch tiết ra. Phương pháp này không hữu hiệu vì khi đã thấy dịch tiết ra thì ở những vị trí này đã có những dấu chứng rõ ràng khác.

- Ấn lên xung quanh nướu. Cách tốt nhất nếu có mủ chảy ra.

2.3. Khám và đánh giá sự phá hủy mô nha chu

Hai mục tiêu chính của khám mô nha chu là ghi nhận độ sâu túi và mức mất bám dính xung quanh răng. Độ sâu túi là khoảng cách từ viền nướu đến đáy túi. Mất bám dính là khoảng cách từ đường nối men-xê măng đến đáy túi. Trong đó mất bám dính là dấu chứng tốt để đánh giá mức độ phá hủy mô nha chu.

Một túi nha chu có thể xuất hiện tại bất kỳ một điểm nào quanh răng, nên khi đo túi, ta phải di chuyển cây đo túi từng bước một quanh răng để ghi nhận điểm sâu nhất của mỗi mặt răng: xa ngoài, ngoài, xa trong, trong và gần trong.

Thăm dò túi phải nhẹ nhàng, không gây khó chịu cho bệnh nhân. Khi đưa cây đo túi vào túi và di chuyển về phía chóp dọc theo bề mặt gốc răng, có thể gặp vôi dưới nướu, lúc đó ta phải di chuyển nhẹ nhàng qua miếng vôi và tiếp tục đưa về phía chóp cho đến khi gặp phải sức kháng lại của mô mềm ở đáy túi. Luôn cố gắng đưa cây đo túi song song với trục dọc của răng. Chỉ khi đo túi ở vùng tiếp giáp giữa hai răng thì mới nghiêng nhẹ cho đến khi chạm tiếp điểm. Ở vùng này, phải đo cẩn thận vì túi hay xuất hiện ở đây. Hầu hết các nhà thực hành lâm sàng không ghi nhận mất bám dính ở lần đầu mà thường vào các lần điều trị duy trì. Có hai lý do chính là do mất bám dính sẽ thay đổi sau điều trị và việc đọc dễ hơn khi màng bám vi khuẩn đã loại bỏ và viêm nhiễm được kiểm soát. Để xác định tiến triển bệnh, tốt nhất ta nên đo mất bám dính vào 2 thời điểm khác nhau. Việc ghi nhận mất bám dính thì khó và mất nhiều thời gian do định vị đường nối men - xê măng như điểm mốc. Nếu nướu viêm tấy nhiều thì đường nối men - xê măng nằm trên mặt chân răng và thấy rõ được nên việc xác định mất bám dính dễ dàng. Tuy nhiên, rất khó xác định nếu viêm nướu phủ đường nối men - xê măng. Trong trường hợp này, đường nối men - xê măng được xác định bằng cảm giác qua đầu cây đo túi.

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến điều trị

2.4.1. Sang thương vùng chẽ

Nhiễm trùng ở vùng này thường gây ra nhiều vấn đề trong điều trị vì vùng chẽ rất khó cho việc làm sạch đối với bệnh nhân lẫn thầy thuốc. Cách tốt nhất để xác định sang thương vùng chẽ là dùng thám thám Nabers.

2.4.2. Niêm mạc nướu *niêm dính (niêm sừng hóa) trên men*

Phải chú ý đến những vùng có nướu dính ít. Ranh giới giữa nướu dính sừng hóa và niêm mạc xương ổ không sừng hóa có thể thấy rõ ràng. Nói chung những vị trí có nướu sừng hóa ít thì không thuận lợi cho việc kiểm soát màng bám. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nhiều bệnh nhân có nướu dính thấp vẫn làm sạch vùng này tốt và không đòi hỏi bất kỳ một can thiệp điều trị nào khác hơn là làm sạch do nha sĩ. Trong bất kỳ trường hợp nào, cũng nên ghi nhận những vị trí có nguy cơ về vấn đề niêm mạc nướu cho kế hoạch điều trị.

2.4.3. Đánh giá răng lung lay

Một trong những nguyên nhân chính làm răng lung lay tăng là mất xương ổ thu phát do nhiễm trùng, đánh giá mất bám dính theo thời gian là một phương pháp tốt để xác định tiến triển bệnh nhưng sự gia tăng lung lay răng theo thời gian. Lung lay được chia theo 3 mức độ:

- Lung lay theo chiều ngoài trong ít hơn 1 mm.
- Lung lay theo chiều ngoài trong > 1 mm nhưng không lung lay theo chiều dọc.
- Lung lay theo chiều ngang và chiều dọc.

Cần nhấn mạnh là lung lay răng tăng có thể do một số nguyên nhân khác. Ví dụ như do răng chịu lực quá tải, sau khi chỉnh hình hay bị nhiễm khuẩn quanh chóp. Cách phát hiện lung lay răng là đặt 1 ngón tay trên mặt trong răng và dùng cán dụng cụ (gương hay cây đo túi) đẩy nhẹ ở mặt ngoài. Ta có thể cảm nhận hay thấy được sự chuyển động so với răng kế cận.

2.4.4. Lập phiếu khám nha chu

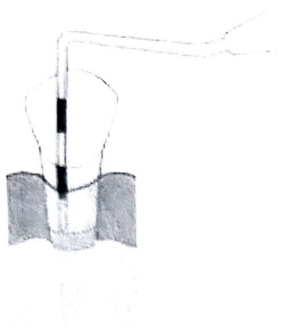
Phiếu khám nha chu phải dễ đọc và chứa đầy đủ các thông tin cơ bản cần thiết cho việc chẩn đoán, tiên lượng và kế hoạch điều trị nha chu. Ngoài ra, nó còn dùng để đánh giá đáp ứng đối với điều trị theo thời gian. Trước khi điều trị tất cả những thông tin thu nhập ở trên phải ghi vào phiếu khám: độ sâu túi của mỗi răng, mất bám dính, mức độ tụt nướu ở từng vị trí, sang thương vùng kẽ...

2.5. Các chỉ số nha chu dùng trong nghiên cứu lâm sàng

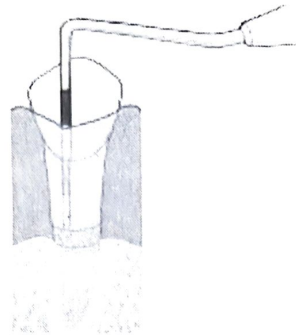
Trong các nghiên cứu, các tác giả thường đặt ra những tiêu chuẩn riêng biệt để mô tả, đánh giá mức độ bệnh nha chu. Chủ yếu là đánh giá viêm nướu và viêm nha chu. Ngoài ra, còn có các chỉ số dùng để đánh giá tình trạng vệ sinh răng miệng và nhu cầu điều trị. Trong giới hạn bài giảng này, chúng tôi chỉ giới thiệu những chỉ số nha chu thường dùng trong nghiên cứu lâm sàng.

Chỉ số độ sâu túi nha chu PD (Pocket Deep): từ vị trí nướu viền đến đáy túi (đầu tận cùng cây thăm dò chạm vào lớp biểu mô kết nối), đơn vị đo là mm.

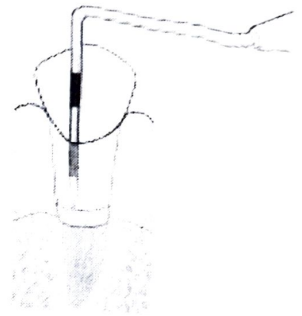
Chỉ số mất bám dính lâm sàng CAL (Clinical Attachment Loss): được tính bằng độ tụt nướu (bờ nướu viền đến đường nối men-xê măng) cộng với độ sâu túi, mất bám dính lâm sàng thay đổi theo vị trí của nướu viền.



PPD = 4 mm
Tụt nướu + 2 mm
CAL = 6 mm



PPD = 9 mm
Nướu phủ - 3 mm
CAL = 6 mm



PPD = 6 mm
Nướu viền 0 mm
CAL = 6 mm

Hình 14.4. Chỉ số CAL thay đổi theo vị trí nướu viền.
(Nguồn: Carranza's Clinical Periodontology, 2015).

2.5.1. Chỉ số nướu GI (gingival index) của Loe và Silness (1963)

Bảng 14.1. Chỉ số nướu GI (gingival index) của Loe và Silness (1963)

Điểm số	Tiêu chuẩn
0	Nướu bình thường.
1	Viêm nhẹ, nướu đổi màu, hơi phù, không chảy máu khi thăm khám.
2	Viêm trung bình, nướu đỏ, phù, chảy máu khi thăm khám.
3	Viêm nặng, nướu đỏ, phù, lở loét, chảy máu tự phát.

Mô nướu quanh răng được chia làm 4 vùng: gai nướu xa ngoài, nướu mặt ngoài, gai nướu gần ngoài và nướu mặt trong. Tổng điểm của 4 vùng này được chia trung bình để có điểm của mỗi răng và chia trung bình để có điểm GI cho mỗi cá thể. GI rất có hiệu quả trong nghiên cứu dịch tễ mô tả và dịch tễ thực nghiệm, bởi vì nó khá nhạy dù có thay đổi nhỏ, dễ đánh giá và cho phép tách biệt từng điểm số khi khám nên giảm tối đa những lỗi giữa các người khám và trong từng người khám. GI cũng thường được chọn trong thử nghiệm lâm sàng.

2.5.2. *Chỉ số chảy máu khe nướu SBI (sulcus bleeding index) của Muhleman và Mazor (1958)*

Bảng 14.2. Chỉ số chảy máu khe nướu SBI

Điểm số	Tiêu chuẩn
0	Không viêm, không chảy máu khi thăm khám.
1	Chảy máu khi thăm khám, nhưng bề mặt nướu bình thường.
2	Chảy máu khi thăm khám và thay đổi màu sắc nướu.
3	Chảy máu khi thăm khám, nướu đổi màu và phù nhẹ.
4	Chảy máu khi thăm khám, nướu đổi màu và phù đỏ.
5	Chảy máu khi thăm khám và chảy máu tự phát, nướu đổi màu, phù nhiều có hay không có lở loét.

Chỉ số này cho thấy mối quan hệ giữa nhiễm khuẩn và chảy máu khi thăm dò. Thường được dùng nhiều trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.

2.5.3. *Chỉ số nha chu PI (Periodontal index) của Rusell (1956)*

Bảng 14.3. Chỉ số nha chu PI

Điểm số	Tiêu chuẩn
0	Bình thường, nướu không viêm, răng không mất chức năng do phá hủy mô nâng đỡ.
1	Viêm nướu nhẹ: một phần nướu viền viêm.
2	Viêm nướu: nướu viêm toàn bộ nhưng biểu mô bám dính không ảnh hưởng.
3	Viêm nướu kèm túi nha chu: biểu mô bám dính bị phá hủy, thành lập túi, chức năng nhai vẫn bình thường.
4	Phá hủy nặng và mất chức năng nhai: răng lung lay có thể trôi lên.

Chỉ số PI đánh giá cả nướu và mô nha chu cùng lúc, đơn giản, thực hiện nhanh nên được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu dịch tễ mô tả (áp dụng cho quần thể lớn). Song không phát hiện những dạng nha chu viêm trung bình, nên không có độ nhạy và chính xác để phát hiện những thay đổi nhỏ trong nghiên cứu tiền cứu hay thử nghiệm lâm sàng. Chính vì vậy mà ngày nay PI ít được dùng.

2.5.4. Chỉ số mảng bám PLI (plaque index) của Loe và Silness (1967)

Bảng 14.4. Đánh giá những vị trí tương tự GI

Điểm số	Tiêu chuẩn
0	Không có mảng bám
1	Không mảng bám thấy bằng mắt nhưng thấy được khi dùng cây thăm dò cao trên mặt răng ở khe nướu
2	Mảng bám thấy bằng mắt
3	Mảng bám, mảnh thức ăn tích tụ nhiều

PLI: nhạy, nên rất hữu hiệu trong những thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu dài hạn.

Khuyết điểm: hơi chủ quan, đòi hỏi người khám phải tập huấn tốt và có kinh nghiệm.

2.5.5. Chỉ số nhu cầu điều trị nha chu cho cộng đồng CPITN (community periodontal index of treatment needs) của Tổ chức Sức khỏe Thế giới

Dùng để đánh giá cả mô nướu và mô nha chu rồi ước lượng nhu cầu điều trị thường dùng trong nghiên cứu dịch tễ mô tả nhằm kiểm soát và giảm tỷ lệ bệnh nha chu trong cộng đồng.

Cách đánh giá nhu cầu điều trị đưa vào cách đánh giá trên một số răng đặc biệt gọi là răng chỉ số với các tiêu chuẩn:

- 1) Nướu viêm.
- 2) Độ sâu của túi nha chu.
- 3) Sự hiện diện của cao răng (trên nướu hoặc dưới nướu hoặc cả hai).

Răng chỉ số: chia hai hàm răng trên và dưới thành 6 sextants

17-14	13-23	24-27
47-44	43-33	34-37

Ghi bằng một số cho mỗi nhóm răng và số ấy diễn tả nhu cầu điều trị nha chu cho nhóm răng đó. Chỉ tính nhu cầu điều trị cho nhóm còn ít nhất là 2 răng. Nếu ở 1 nhóm chỉ còn một răng, thì răng đó được kể vào nhóm kế bên.

Vì CPITN chỉ dùng để tính nhu cầu điều trị cho một cộng đồng, cho nên không cần phải khám tất cả các răng, mà chỉ khám trên 6 răng đại diện cho nhóm.

17 hay 16	11	26 hay 27
47 hay 46	31	36 hay 37

Nếu cả hai răng cối đều hiện đủ ở một nhóm cũng chỉ ghi bằng một số và số này là của răng có tình trạng xấu nhất.

Nếu ở một nhóm không có răng đại diện thì phải khám tất cả các răng còn lại và ghi bằng một số, số này là của răng có tình trạng xấu nhất.

Chuẩn về nhu cầu điều trị

- Chuẩn 0: mô lành mạnh.
- Chuẩn 1: chảy máu nướu trong khi hoặc sau khi thăm dò.
- Chuẩn 2: có cao răng nhìn thấy trực tiếp hoặc bằng cảm giác qua cây thăm dò.
- Chuẩn 3: túi 4 hoặc 5 mm.
- Chuẩn 4: túi > 6 mm.

Nhu cầu điều trị

- TN 0 (chuẩn 0): không cần điều trị.
- TN 1 (chuẩn 1): người bệnh phải được hướng dẫn vệ sinh răng miệng.
- TN 2 (chuẩn 2): cạo vôi răng.
- TN 3 (chuẩn 3): túi sâu vừa nhưng có thể điều trị cạo cao răng.
- TN 4 (chuẩn 4): điều trị phức tạp: cạo vôi và xử lý bề mặt chân răng bằng

phương pháp phẫu thuật hay không phẫu thuật.